

Rapport de Situation de la 17^e Épidémie de la maladie à Virus Ebola / RDC

SitRep N°145 /MVE-BDBV/06/10/2026

Date du rapport : 06 octobre 2026

Date de publication : 07 octobre 2026



FAITS SAILLANTS (dernières 24h)

- Soixante-trois (63) nouveaux cas confirmés de la Maladie à Virus Ebola (MVE), dont 17 décès communautaires, ont été notifiés. Ces cas provenaient des provinces de l'Ituri (33 cas) et du Nord-Kivu (30 cas). De plus, 10 décès ont été enregistrés dans les CTE
- Un total de 523 nouveaux échantillons a été analysé ; 63 de ces échantillons se sont révélés positifs au virus Bundibugyo, soit 12,0 % de positivité.

CUMUL DES
CAS
8 728

CUMUL DES
DÉCÈS
CONFIRMÉS
4 205

LETALITE
48,2 %

PATIENTS EN
ISOLEMENT/CTE
1066

CUMUL DES
GUÉRIS
2 269

TAUX DE SUIVI DES
CONTACTS
(Du Jour)
82,0%



Provinces touchées et zones de santé touchées



7 Provinces touchées
Haut-Uélé, Ituri, Nord-Kivu,
Sud-Kivu, Tshopo, Bas-Uélé et
Sud Ubangi



64 Zones de santé touchées sur 167 (38,3%)

Résumé des points clés au cours des dernières 24 heures

En date, 63 nouveaux cas confirmés de la Maladie à Virus Ebola (MVE) dont 17 décès communautaires ont été notifiés dans 2 provinces : l'Ituri (33 cas) et le Nord-Kivu (30 cas).

De plus, 10 décès ont été enregistrés dans les CTE (8 en Ituri, 1 au Nord-Kivu et 1 à la Tshopo (1), ce qui porte à 27 le nombre total des décès confirmés pour la période concernée.

En revanche, 10 patients (4 en Ituri, 4 au Haut-Uélé, 2 au Nord Kivu) ont été déclarés guéris après avoir obtenu deux résultats négatifs au test de contrôle à la MVE.

Pour le 06 octobre 2026, la RDC cumule **8 728** cas confirmés et **4 205** décès, soit une létalité de **48,2 %**. L'Ituri demeure l'épicentre de l'épidémie avec **74,6 %** des cas confirmés cumulés et **52,4 %** des nouveaux cas confirmés rapportés au cours des dernières 24 heures.

64 zones de santé sur 167 (38,3 %), réparties dans sept provinces, ont été touchées depuis le début de l'épidémie.

Tableau 1. Répartition des cas et décès confirmés par province touchée, au 06 octobre 2026.

Province	Nouveaux cas confirmés(24h)	Cas confirmés	Décès (confirmés)	Létalité	Zones de santé touchées
Ituri	33	6513	3 007	46,2%	28/36 (77,8 %)
Nord-Kivu	30	1785	1 021	57,2%	17/34 (50,0 %)
Haut-Uélé	0	364	153	42,0%	7/13 (53,8 %)
Tshopo	0	51	18	35,3%	7/23 (30,4 %)
Sud-Kivu	0	3	1	33,3%	1/34 (2,9 %)
Bas-Uélé	0	10	4	40,0%	3/11 (27,3%)
Sud Ubangi	0	2	1	50,0%	1/16 (6,3%)
Total	63	8 728	4 205	48,2%	64/167 (38,3 %)

Tableau 2. Répartition des cas et décès confirmés par province et zone au 06 octobre 2026

Province / Zone de santé	Nombre cumulatif			Situation du jour (24h)			
	Cas (n)	Décès (n)	Létalité	Nouv. Cas	Décès communautaires (Swab+)	Décès confirmés intra-CTE	Total décès confirmés
Ituri	6513	3007	46,2%	33	10	8	18
Adja	12	1	8,3%	1			0
Aru	8	6	75,0%				0
Ariwara	8	2	25,0%				0
Aungba	12	5	41,7%				0
Bambu	210	47	22,4%			1	1
Boga	2	2	100,0%				0
Bunia	1790	594	33,2%	7	5	1	6
Damas	40	9	22,5%				0
Drodro	15	7	46,7%				0
Fataki	84	31	36,9%	1			0
Gethy	9	5	55,6%				0
Kambala	2	0	0,0%				0
Kilo	38	12	31,6%				0
Komanda	176	107	60,8%	1			0
Lita	295	148	50,2%	1	0	1	1
Logo	14	6	42,9%			1	1
Lolwa	35	9	25,7%	1			0
Mahagi	4	1	25,0%				0
Mambasa	41	17	41,5%	4	1		1
Mandima	198	98	49,5%	3	1		1
Mangala	366	157	42,9%	1	0	0	0
Mongbwalu	710	337	47,5%	3	0	1	1
Nia-Nia	314	175	55,7%	3	0	0	0

Nizi	792	286	36,1%	4	3	1	4
Nyankunde	130	37	28,5%				0
Rimba	14	5	35,7%				0
Rwampara	1118	385	34,4%	3		2	2
Tchomia	76	25	32,9%				0
A ventiler	NA	493	NA				0
Nord-Kivu	1785	1021	57,2%	30	7	1	8
Beni	409	268	65,5%	9	4	0	4
Biena	23	7	30,4%	3	0	0	0
Butembo	286	180	62,9%	3			0
Goma	1	0	0,0%				0
Kalunguta	63	22	34,9%	2	1	0	1
Katwa	608	373	61,3%	2	0	1	1
Kayna	3	2	66,7%				0
Kyondo	37	20	54,1%	1	0		0
Lubero	23	11	47,8%	1	0	0	0
Mabalako	51	20	39,2%				0
Alimbongo	5	3	60,0%	1	1	0	1
Manguredjipa	13	5	38,5%				0
Masereka	34	11	32,4%	2	0		0
Musienene	140	69	49,3%	2	0	0	0
Mutwanga	20	4	20,0%	3	1	0	1
Oicha	34	16	47,1%	1	0	0	0
Vuhovi	35	10	28,6%				0
Haut-Uélé	364	153	42,0%	0	0	0	0
Boma Mangbetu	43	19	44,2%				0
Dungu	1	1	100,0%				0
Gombari	3	1	33,3%				0
Isiro	102	44	43,1%				0
Pawa	92	43	46,7%				0
Rungu	4	2	50,0%				0
Wamba	119	43	36,1%				0
Tshopo	51	18	35,3%	0	0	1	1
Bafwasende	7	1	14,3%				0
Kabondo	5	1	20,0%				0
Lubunga	1	0	0,0%				0
Makiso-Kisangani	27	11	40,7%				0
Mangobo	8	4	50,0%	0	0	1	1
Tshopo	2	0	0,0%				0
Wanie-Rukula	1	1	100,0%				0
Sud-Kivu	3	1	33,3%	0	0	0	0
Miti-Murhesa	3	1	33,3%				0
Bas Uélé	10	4	40,0%	0	0	0	0

Buta	1	1	100,0%				0
Viadana	6	1	16,7%				0
Ganga	3	2	66,7%				0
Sud Ubangi	2	1	50,0%	0	0	0	0
Bulu	2	1	50,0%				0
Total	8728	4205	48,2%	63	17	10	27

*Il s'agit des décès confirmés survenus dans les différents CTE de la province qui sont en cours de ventilation pour être classifiés par zone de santé.
NA : Non Applicable.

Tableau 3. Situation des alertes notifiées par province pour la journée du 06 octobre 2026

DPS	Alertes Reçues		Total alertes	Alertes vérifiées et validées (cas suspect)		Alertes vérifiées et invalidées (non-cas suspect)		Nombre de suspects investigués	Nombre de suspects investigués et transférés au CT/CTE (du jour)
	Vivants	Décédés		Vivants	Décédés	Vivants	Décédés		
Haut-Uélé	128	5	133	22	5	106	0	27	19
Bas Uélé	165	2	167	13	2	152	0	15	0
Ituri	1 227	80	1 307	141	77	1 086	3	218	110
Nord-Kivu	1 257	63	1 320	167	62	1 090	1	229	125
Sud Ubangi	42	1	43	1	1	41	0	2	0
Tshopo	64	1	65	2	1	62	0	3	2
Total Général	2 883	152	3 035	346	148	2 537	4	494	256

Figure 1. Évolution de cas par date de début des symptômes au cours des 21 derniers jours

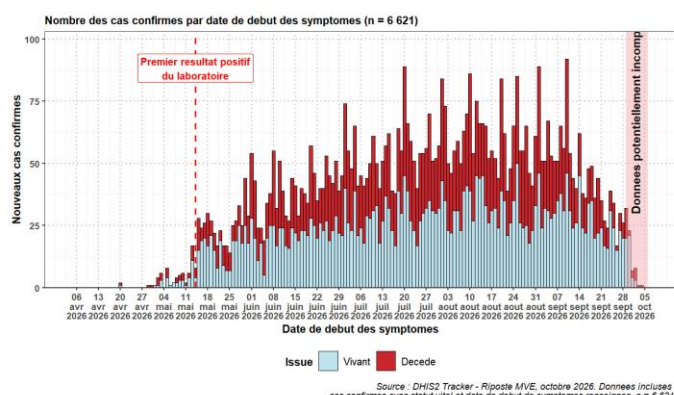
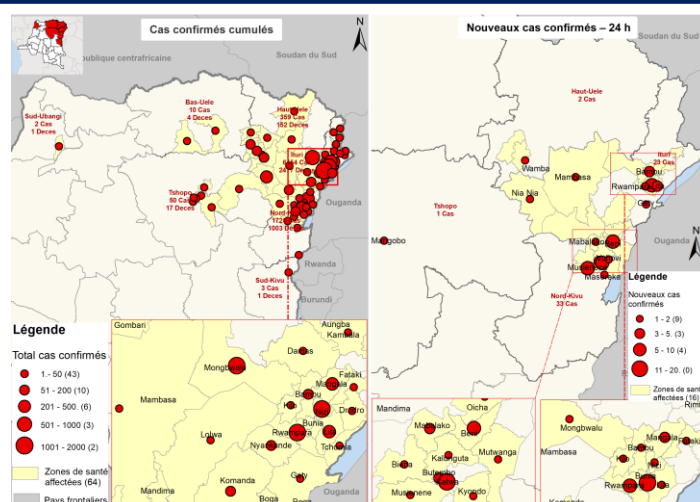


Figure 2. Distribution spatiale des cas confirmés (24 heures et cumuls) par zone de santé.



1. COORDINATION

1.1. Principales Actions

- Appui aux activités de réponse dans les provinces affectées à travers les piliers techniques.

2. ACTIONS DE RIPOSTE PAR PILIER

2.1. Surveillance épidémiologique

2.1.1. Principales Actions

Pour la journée du 06 octobre 2026, **3 035** alertes ont été rapportées dans les six provinces ayant notifié des alertes et toutes ont été vérifiées (**100 %**) : **494 (16,3 %)** ont été validées comme cas suspects et **2 541 (83,7 %)** invalidées. Les 494 cas suspects validés ont tous été investigués (100 %). Parmi eux, **256 (51,8 %)** ont été transférés vers les CT/CTE (Tableau 3).

Parmi **31 832 contacts en cours de suivi**, **26 105 ont été vus au cours des dernières 24 heures**, soit une proportion de suivi de **82,0 %**, en hausse par rapport à la veille (**80,4 %**), mais toujours inférieure au seuil requis de **95,0 %**. Cette proportion était de **83,0 % (12 569/15 145) en Ituri**, **80,2 % (11 452/14 281) au Nord-Kivu**, **87,3 % (1 698/1 944) au Haut-Uélé**, **79,8 % (225/282) à la Tshopo**, **89,7 % (122/136) au Bas-Uélé** et **88,6 % (39/44) au Sud-Ubangi**

2.2. Point sur les activités de points de contrôle et points d'entrées (PoE/PoC)

2.2.1. Principales actions

Deux (2) alertes ont été notifiées aux PoE/PoC repris au cours de la journée du 06 octobre, toutes au Nord-Kivu, aux PoC de Mukulya et de Mavivi Barrière (ZS de Beni) ; il s'agissait de deux alertes vivantes, invalidées après vérification. Au Bas-Uélé, province non reprise au Tableau 4, 11 alertes ont été notifiées aux PoC de Koteli (7) et de Sukisa (4) dans la ZS de Koteli, toutes invalidées par l'IT, ce qui porte à 13 le total national des alertes notifiées aux PoE/PoC.

Tableau 4. Situation indicateurs clés des PoE/PoC par province, en date du 06 octobre 2026

Indicateurs	Ituri	Nord-Kivu	Tshopo	Global
Complétude des rapports	96,7% (58/60)	95,2% (20/21)	100,0% (18/18)	97,0% (96/99)
% des PoE/PoC stratégiques fonctionnels	100%	100%	100%	100%
Nombre de personnes passées aux PoE/PoC	147 769	92 375	18 763	258 907
% des voyageurs screenés	97,2%	98,0%	98,3%	97,5%
% des voyageurs ayant lavé les mains	96,8%	98,0%	98,1%	97,3%
% des voyageurs sensibilisés	99,6%	98,0%	100,0%	99,0%
Nombre d'alertes notifiées	0	2	0	2
Nombre d'alertes vivantes validées (cas suspects)	0	0	0	0
Nombre de corps sans vie interceptés ce jour	0	0	0	0
% des cas suspects transférés au CTE/CT	NA	NA	NA	NA
% des corps sans vie swabés/sécurisés	NA	NA	NA	NA
% des cas suspects investigués dans 4 h	NA	NA	NA	NA

2.2.2. Défis

Au Nord-Kivu, le PoC de Butuhe ne fonctionne plus depuis l'incident sécuritaire du 26 septembre, 1 837 voyageurs (2,0 %) ont refusé le screening, dont 511 (11,8 %) au PoC de Makeke, et les alertes remontées des PoC ne sont pas prises en charge dans les délais par les cellules d'alerte. Au Sud-Kivu, la complétude des rapports n'est que de 55,6 % (5/9) et les PoE de Kavimvira, Kalundu Port et Baraka ne disposent d'aucun dispositif d'isolement. Au Bas-Uélé, seuls 19 PoC sur 41 sites de notification sont fonctionnels (46,3 %), aucun PoE n'est renforcé (0/11) et les services du PNHF ne sont pas opérationnels.

2.3. Laboratoire

2.3.1. Principales actions

- **Ituri : 33 nouveaux résultats positifs** (23 vivants et 10 décès) sur 221 échantillons reçus et analysés (**positivité : 14,9 %**).
- **Nord-Kivu : 30 nouveaux résultats positifs** (23 vivants et 7 décès) sur 265 échantillons reçus et analysés (**positivité : 11,3%**).
- **Haut-Uélé : 6 nouveaux échantillons** (5 vivants et 1 décès) tous sont revenus négatifs.
- **Tshopo : 14 nouveaux échantillons (14 sang) reçus et analysés, tous sont revenus négatifs**
- **Bas Uélé : 17 échantillons** (17 sangs) reçus et analysés au laboratoire de Buta, **tous sont revenus négatifs**.

2.4. Prévention et Contrôle de l'Infection (PCI/EDS)

2.4.1. Principales actions

- **Ituri** : 20 rings ont été ouverts sur 40 (50,0 %), 44 ménages décontaminés sur 60 (73,3 %) et 4 FOSA décontaminées sur 8 (50,0 %) ; aucun ménage, ESS ni école n'a été doté en kits. Sur 100 alertes EDS (dont 8 reports de la veille), 78 EDS ont été réalisés (78,0 %) et 69 corps swabés.
- **Haut-Uélé** : 1 ESS sur 1 (100 %) a été décontaminée à Pawa et 36 prestataires ont été briefés lors de la visite de 10 ESS à Isiro, Boma Mangbetu, Wamba et Pawa ; aucun ring n'a pu être ouvert autour des 5 cas ciblés à Wamba (4) et à Boma Mangbetu (1). Sur 5 alertes EDS, 3 EDS ont été réalisés (60,0 %) et 3 corps swabés, et l'UNICEF a affecté 2 véhicules à l'équipe de décontamination de Dungu..
- **Tshopo** : 5 auditories et 580 bancs de la Faculté de Médecine (cas n°49) ainsi que 7 locaux et 2 latrines autour du cas n°51 (ZS de Tshopo) ont été décontaminés, avec incinération de 2 matelas, 2 draps et 1 poubelle ; 18 ESS sur 18 ont été suivies dans 6 ZS et 186 prestataires briefés (100 %). En cumul, 40 ESS sur 40 (100 %) et 30 ménages sur 33 (90,9 %) ayant accueilli un cas confirmé ont été décontaminés dans les 48 heures. Quant aux EDS, 3 alertes ont été reçues (CTE, HGR de Makiso-Kisangani et morgue Rekapi II), 3 corps ont été swabés et 1 EDS a été réalisé pour 2 corps à Kibali Gold.
- **Bas-Uélé** : 9 ESS sur 9 (100 %) ont été suivies à Viadana, Buta et Ganga, avec le briefing de 10 prestataires sur 10 et de 19 hygiénistes sur 19 (100 %) ; une formation en cascade sur la PCI a débuté à Viadana au profit de 35 prestataires de 6 ESS, avec l'appui de FHI 360. Aucun EDS n'a été réalisé, mais 2 swabs ont été effectués à Poko (AS Kisanga) et à Bili (AS Dumobata).

2.4.2. Défis

Au Haut-Uélé, seules 4 ZS sur 7 ont rapporté leurs activités PCI, les kits PCI destinés aux ménages manquent et la décontamination autour d'un cas confirmé décédé le 05 octobre s'est heurtée à une résistance communautaire. **À la Tshopo**, les intrants PCI et les prestataires formés restent insuffisants, l'incinérateur de l'HGR de Makiso-Kisangani est toujours en panne et les morgues Rekapi I et II manquent de kits de prélèvement et d'EPI. **Au Bas-Uélé**, la remontée des alertes de décès communautaires reste faible et 2 triages sur 3 suivis à Buta ne sont pas fonctionnels faute de personnel dédié.

2.5. Vaccination

2.5.1. Principales actions

- **Au Bas-Uélé**, la vaccination des PPL et TPL s'est poursuivie dans la ZS de Poko, avec le préenregistrement des leaders religieux, RECO, tradipraticiens, motards et chasseurs, portant le cumul provincial à 1 412 personnes vaccinées sur une cible de 13 202 (10,7 %), principalement à Buta (620 ; 21,6 %), à Ganga (273 ; 20,5 %) et à Poko (150 ; 11,0 %).
- **En Ituri**, les essais cliniques Partners, Oracle et EBO-PEP se sont poursuivis avec l'appui de l'INRB, de Kivu et d'ALIMA, et un protocole de recherche sur l'impact de l'épidémie sur l'utilisation des services de santé sexuelle et reproductive a été reçu pour analyse.

2.5.2. Défis

En Ituri, la vaccination des PPL et l'étude de l'immunité croisée avec la souche BDBV restent suspendues dans l'attente de l'approvisionnement en vaccin Ervebo par le PEV national.

Au Bas-Uélé, la mise en marche des UCC n'est pas effective et le micro-plan validé ainsi que les fonds de la vaccination ne sont toujours pas disponibles.

2.6. Continuité des Soins

2.6.1. Principales actions

- **À la Tshopo**, l'évaluation du CS Ville (ZS de Makiso-Kisangani) a révélé l'absence de maternité depuis plus de 3 ans, de laboratoire et d'incinérateur, une zone de triage non effective, 2 cas de MAS non pris en charge faute d'intrants (ATPE, F75, F100 et ReSoMal) et un seul agent vacciné sur 18 (5,6 %) ; le plan de redressement du CM Sendwe a été élaboré et le suivi des PPL au CTM et au CTE ainsi que celui des guéris présentant des comorbidités à l'HGR de Makiso-Kisangani se sont poursuivis.
- **Au Haut-Uélé**, un sondage rapide sur les raisons de la faible utilisation des services de soins a démarré dans l'AS de Kolu (ZS d'Isiro), avec 28 ménages enquêtés sur une centaine ciblés

2.7. Communication sur les risques et engagement communautaire (CREC)

2.7.1. Principales actions

- **En Ituri**, 15 798 visites à domicile ont touché 77 209 personnes ; 1 078 causeries éducatives ont réuni 11 150 personnes, 304 sensibilisations de masse 8 202 personnes, 14 débats communautaires 691 personnes et 12 plaidoyers 44 autorités et leaders ; 24 spots ont été diffusés sur 36 stations de radio et 6 émissions organisées. Au total, 247 alertes communautaires, dont 72 décès, ont été notifiées ; 37 feedbacks sur 55 (67,3 %) et 1 incident sur 4 (25,0 %) ont été résolus dans les 48 heures, et 5 guéris ont été réinsérés à Tsere lors d'une sensibilisation ayant réuni 105 personnes. Seules 11 ZS sur 28 (39,3 %) ont transmis leur rapport CREC.
- **Au Bas-Uélé**, 8 séances de sensibilisation de masse en milieu scolaire ont touché 1 250 personnes à Ganga, Poko, Likati et Viadana et 132 visites à domicile 525 personnes à Ganga et à Viadana ; 2 alertes communautaires ont été notifiées et résolues.
- **Au Nord-Kivu**, 10 654 visites à domicile ont touché 34 721 personnes, 230 causeries éducatives ont touché 7 449 personnes et 63 séances de communication de masse ont atteint 8 368 personnes ; 201 alertes communautaires sur 750 attendues (26,8 %) ont été notifiées, 13 feedbacks sur 17 (76,5 %) ont été résolus dans les 48 heures et 910 personnes sur 4 750 attendues (19,2 %) se sont engagées dans les actions communautaires.
- **À la Tshopo**, 7 séances de sensibilisation de masse ont touché 17 466 personnes à Bafwasende, Tshopo, Mangobo et Makiso-Kisangani, 202 visites à domicile 1 176 personnes et 3 causeries éducatives 209 personnes ; 57 alertes communautaires ont été notifiées, 2 refus sur 3 ont été levés et 186 dépliants et 192 affiches distribués, et l'incident lié à l'attaque d'une équipe de riposte sur la 7e avenue TP (ZS de Kabondo) a été traité.
- **Au Haut-Uélé**, 94 causeries éducatives, 7 séances de masse et 212 visites à domicile ont touché 3 843 personnes ; 43 alertes communautaires, dont 5 décès, ont été notifiées et les 15 feedbacks reçus ont été résolus (100 %), la plupart portant sur une perception de négligence des patients au CTE de Pawa.

2.8. Santé mentale et soutien psychosocial (SMSPS)

2.8.1. Principales actions

- **Nord-Kivu**, 30 derniers cas confirmés sur 33 (90,9 %), 246 confirmés en cours de suivi, 223 nouveaux suspects et 676 suspects en cours de suivi ont bénéficié d'interventions SMSPS. Les équipes ont accompagné 66 ménages pour les actions de santé publique, soutenu 87 PPL, suivi 8 guéris sur 8 en communauté (100 %), réalisé la psychoéducation de 304 personnes (117 hommes, 146 femmes et 41 enfants) avec l'appui de l'UNICEF et annoncé 145 résultats, dont 39 positifs.
- **En Ituri**, 8 derniers cas confirmés sur 30 (26,7 %), 84 confirmés en cours de suivi sur 141 (59,6 %), 53 nouveaux suspects sur 75 (70,7 %) et 105 suspects en cours de suivi sur 156 (67,3 %)

ont bénéficié d'interventions SMSPS. Les équipes ont soutenu 275 accompagnants et 60 PPL, suivi 18 guéris sur 20 (90,0 %) en communauté et 15 enfants sur 15 en crèche, accompagné 16 ménages d'enfants séparés et orphelins sur 19 (84,2 %), réinséré 4 guéris sur 4, réalisé 2 admissions en crèche et 2 réunifications familiales, et annoncé 31 résultats, dont 8 positifs

- **À la Tshopo**, le dernier cas confirmé et les 6 confirmés en cours de suivi, ainsi que 4 nouveaux suspects sur 4 et 10 suspects en cours de suivi sur 10, ont été pris en charge (100 %) ; les équipes ont soutenu 9 PPL et 3 ménages, suivi 1 guéri en communauté, levé 3 résistances sur 3 (église Assemblée des Saints, CM Bolila et CM Massimiliano), réalisé la psychoéducation de 947 personnes, dont 880 élèves à Lubunga et à Kabondo, et annoncé 4 résultats, dont 1 positif ; 5 ZS sur 7 ayant notifié sont couvertes (71,4 %).
- **Au Haut-Uélé**, 5 cas confirmés récents, 26 confirmés en cours de suivi, 4 nouveaux suspects et 20 suspects en cours de suivi ont bénéficié d'interventions SMSPS dans les CTE d'Isiro, Pawa, Boma Mangbetu et Wamba ; les équipes ont soutenu 49 accompagnants, 82 PPL (dont 25 membres de la coordination nationale), 10 enfants séparés en communauté et 15 membres de ménages, appuyé 3 EDS et annoncé 37 résultats, dont 8 positifs
- **Au Bas-Uélé**, 5 PPL, 6 membres de ménages et de la communauté et 3 contacts ont été soutenus, 2 guéris déchargés sont suivis, 3 résultats ont été annoncés (tous négatifs) et la réinsertion de 2 guéris de la ZS de Viadana a été préparée avec le pilier CREC).

2.8.2. Défis

- **En Ituri**, seules 14 ZS affectées sur 28 sont couvertes (50,0 %) et la ZS de Mandima n'a aucune couverture SMSPS, ce qui impose de renforcer les capacités des psychologues et des APS/TPS pour assurer les interventions autour des cas.
- **Au Bas-Uélé**, la couverture SMSPS reste embryonnaire, les activités venant à peine de démarrer dans la ZS de Viadana.
- **Au Haut-Uélé**, la mobilité des APS reste difficile à Wamba et à Boma Mangbetu, les kits nutritionnels manquent pour les nourrissons sevrés à Wamba et à Isiro, le pilier ne dispose pas de matériel informatique et la remontée des données reste faible à Boma Mangbetu et à Pawa
- **À la Tshopo**, nécessité de former les APS des ZS de Wanie-Rukula et de Bafwasende et insuffisance des unités de communication et des motos pour les déplacements du pilier.

2.9. Logistique

2.9.1. Principales actions

- **Au Bas-Uélé**, déploiement des équipes de surveillance à Ganga et à Viadana pour le suivi des contacts, la vérification des alertes et la recherche active, appui à l'enregistrement des membres du SGI, de la sécurité et de la coordination stratégique, pose des fenêtres de la salle de réunion de la DPS, peinture des bureaux Hygiène et Enseignement avec l'appui de l'OMS et poursuite de la construction du CTE de l'HGR de Buta, dont les murs de pourtour sont achevés.
- **À la Tshopo**, validation de la check-list du monitoring logistique, finalisation des états de besoins, suivi de la construction du CTE de Bafwasende, de l'extension du CTE Météo et de l'isolement de Konga-Konga, touché par les travaux d'aménagement de la route, et appui à la mobilité des piliers PCI, PEC, Communication et PoE/PoC ; le besoin en mobilité des ZS reste estimé à 154 motos.
- **En Ituri**, 15 ambulances sur 33 ont été mobilisées et 25 patients ont été évacués vers les structures de prise en charge.
- **Au Haut-Uélé**, 6 courses d'ambulance ont permis de transporter 6 patients à Boma Mangbetu (3), Wamba (2) et Pawa (1), et l'UNICEF a affecté 2 véhicules à la ZS de Dungu pour l'équipe de décontamination.

2.10. Sécurité

2.11. Principales actions

- **À la Tshopo**, le point focal du pilier surveillance de la ZS de Kabondo a été grièvement blessé à la tête à coups de machette lors d'une investigation, et une équipe de riposte a été attaquée par la communauté sur la 7e avenue TP (ZS de Kabondo) lors de la recherche des contacts autour du décès communautaire d'un évadé MVE
- **Au Nord-Kivu**, le PoC de Butuhe (ZS de Kalunguta) reste fermé depuis l'incident sécuritaire du 26 septembre 2026 qui a coûté la vie à un prestataire, et la menace persiste contre les prestataires des PoC de l'axe Butembo.

2.12. PSEA (Prévention de l'Exploitation et Abus Sexuels)

2.12.1. Principales actions

- **En Ituri**, 43 participants (23 femmes et 20 hommes), dont des prestataires du CTE, des journaliers pointeurs et un nouveau staff de Mercy Corps, ont été briefés sur la PSEAH et ont signé le code de bonne conduite dans la ZS de Bunia ; 40 motards de triporteurs, vendeuses de roseaux et réparateurs de motos (21 hommes, 9 femmes, 3 filles et 7 garçons) ont été sensibilisés, et l'affichage des messages ainsi que la distribution des dépliants se sont poursuivis à Bunia, Aru, Mongbwalu, Mambasa et Fataki ; seules 13 ZS sur 36 (36,1 %) connaissent le mécanisme de signalement.

2.12.2. Défis

Au niveau national, seule 1 DPS sur 7 (14,3 %) a rapporté ses activités PSEA ; en Ituri, les activités ne couvrent pas encore toutes les ZS touchées, les supports de sensibilisation de masse manquent et la cartographie des intervenants reste incomplète.

MESSAGES CLÉS

- Dans les provinces de l'Ituri, du Nord-Kivu et du Haut-Uélé, il s'observe une transmission communautaire active tandis qu'une notification sporadique est observée dans la province de la Tshopo.
- 2. Au cours des dernières 24 heures.
- Au cours des dernières 24 heures, tous les cas suspects (100,0%) ont été investigués ; des performances consolidées au regard des données transmises par les provinces. Cependant, le suivi des contacts demeure fluctuant (82,0 % vs 80,4 %) et mérite une attention particulière afin d'éviter des chaînes de transmission non contrôlées. Maintenir un niveau de vigilance en ce qui concerne les aspects de surveillance épidémiologique, consolider les actions PCI et CREC au niveau des communautés tout en offrant des soins de qualité dans les structures de prise en charge dédiées avec des capacités d'accueil adéquates.

CHRONOLOGIE DES FAITS CLÉS

- Du 24 avril au 15 mai 2026, l'épidémie est passée de la détection des premiers cas suspects à la confirmation biologique du virus Ebola Bundibugyo, conduisant à la déclaration officielle de la 17^e épidémie de Maladie à Virus Ebola en République Démocratique du Congo.
- Entre le 17 et le 18 mai 2026, les autorités nationales, avec l'appui des partenaires, ont renforcé la riposte par la déclaration de l'urgence de santé publique de portée nationale puis continentale, accompagnée de la mobilisation des fonds.



TASK FORCE PRESIDENTIELLE EBOLA 17
Ministère de la Santé Publique, Hygiène et Prévoyance Sociale
Institut National de Santé Publique
Centre d'Opérations d'Urgence de Santé Publique
Système de gestion de l'incident MVE17

Directeur Général de l'INSP

Dr MWAMBA KAZADI Dieudonné

E-mail : dieudonne.mwamba@insp.cd

Incident Manager

Professeur Dr AHUKA MUNDEKE Steve

E-mail : steve.ahuka@unikin.ac.cd

Chargé des opérations

Dr KOMBE NGWAMA John

Equipe de rédaction

Professeur Dr MULANGU KATULUMBA Félix-Médard

Dr KATUSI BISELENGE Jules

Madame MAYELE AFUA Marie

Dr DIUR MANANASHI Floryan

Mr KAMUINA KEBELA John

Contact :

www.insp.cd

contact@sgiebola17.org

Numéro vert : 151. www.sante.gouv.cd